



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

OTIMIZAR RECURSOS
GERAR EFICIÊNCIA



Recomendações Técnicas para a Sala de Emergência

RT 14/2019



REPÚBLICA
PORTUGUESA

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAUDE.PT



Recomendações Técnicas para a Sala de Emergência

Ficha técnica

Número
Data de aprovação
Data de publicação
Data última revisão
Revisão obrigatória

Equipa técnica

Autor	UIE/DRS/ACSS
Coordenação	UIE/DRS/ACSS
Edição	UIE/DRS/ACSS

Palavras-chave

Sala de Emergência

Resumo

O presente documento analisa espaços e soluções organizativas da Sala de Emergência.

Base legal

Esta publicação é efetuada nos termos e para os efeitos da alínea r), do artigo 5º da Portaria nº 155/2012 de 22 de maio, tendo em atenção as atribuições da ACSS, IP previstas no artigo 3º do DL nº 25/2012 de 15 de fevereiro.

ISSN:

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, salvo com autorização por escrito do editor, de parte ou totalidade desta obra.

Índice

1.	PREÂMBULO.....	7
2.	METODOLOGIA.....	7
3.	ENQUADRAMENTO:.....	7
4.	CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO	8
5.	BIBLIOGRAFIA:.....	13
6.	GRUPO DE TRABALHO	14

Recomendações Técnicas para a Sala de Emergência

1. PREÂMBULO

Esta versão tenta integrar os comentários apontados na RN de 2019-02-13 com o grupo de trabalho da Comissão de Trauma.

2. METODOLOGIA

Pretende-se com este documento esclarecer as funcionalidades e as características dos espaços eventualmente a considerar numa Sala de Emergência. Assim, a Recomendação Técnica ACSS referente ao Serviço de Urgência remeterá para o presente documento o respeitante à Sala de Emergência.

Estas recomendações vão além das diversas Portarias relacionadas com unidades privadas de saúde. Enquanto as Portarias estabelecem os mínimos exigidos para os licenciamentos de unidades privadas procura-se agora caracterizar espaços e instalações de forma a possibilitar a melhoria dos respetivos desempenhos.

Entendendo-se que um programa funcional especifica a área e o esquema de funcionamento particular de cada Sala de Emergência, este documento faz uma abordagem mais genérica pretendendo referir a generalidade de meios e logísticas a prever numa Sala de Emergência.

Foi, portanto, compilada uma listagem de todos os equipamentos e funcionalidades que poderão existir numa Sala de Emergência ainda que com risco de, nesta enumeração, haver incompatibilidades, redundâncias ou desproporções. Faz-se depois a caracterização funcional e técnica destes mesmos espaços, quando relevante.

Apresentam-se finalmente algumas observações relativas a pormenorização arquitetónica.

3. ENQUADRAMENTO:

A Sala de Emergência (podendo a mesma ter outras designações consoante a organização e cultura local de cada hospital) constitui a interface entre a emergência pré-hospitalar e a urgência hospitalar, sendo por isso uma área fundamental para a mais correta abordagem do doente emergente, grave e crítico. Existe ainda uma Sala de Emergência extra hospitalar na situação específica do SUB – Serviço de Urgência Básico (conforme o definido na legislação aplicável: Despacho nº 18459/2006, Despacho nº 727/2007 e Despacho nº 10319/2014). . Seja qual for o enquadramento, constitui uma área específica de abordagem, tratamento e observação de doentes críticos classificados de emergentes ou, nalguns casos, muito urgentes que apresentem quadro clínico de descompensação das funções vitais que coloque a vida em risco.

Para a melhor abordagem, tratamento e estabilização do doente mais grave importa sistematizar os requisitos arquitetónicos e técnicos a atender, nos diversos cenários, havendo particularidades especialmente relevantes para os Serviços de Urgência Polivalentes.

Assim, a Unidade de Instalações e Equipamentos da ACSS, em colaboração com a Comissão Nacional de Trauma e Peritos de apoio à Comissão Nacional de Trauma indicados pela Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros e diversas Sociedades Científicas, procedem com a sistematização do requerido e recomendado (consoante o aplicável) no caso da construção, organização e manutenção da Sala de Emergência.

A Sala de Emergência deve dispor das logísticas necessárias para o apoio muito urgente ou emergente, considerando o tratamento de doentes em estado crítico, com condições para suporte avançado de vida. A evolução dos conceitos implica o reconhecimento que a Sala de Emergência não é apenas o local para a reanimação cardiorrespiratória, mas, também, fruto da crescente organização dos cuidados em Circuitos de Encaminhamento (clinical pathways and patient streaming according to acuity) um local vocacionado para a Avaliação e Estabilização, o que requer maior capacidade logística. Assim, por norma todos os espaços de prestação de cuidados na Sala de Emergência deverão ser normalizados relativamente às logísticas disponíveis, aos procedimentos possíveis, aos acessos aos equipamentos e aos posicionamentos das equipas.

Adicionalmente, requisitos específicos como os respeitantes ao Trauma ou à Pediatria exigem a consideração de particularidades técnicas. As áreas e meios a considerar devem ser diferenciados para adultos e crianças,

consoante o aplicável. O adiante descrito é genericamente aplicável às diversas situações, com maior especificidade para o doente adulto.

Estas Recomendações Técnicas para Salas de Emergência abrangem os requisitos Gerais e de Trauma atendendo ao estado da arte atual e o preconizado por um conjunto de organismos internacionais e consensos entre entidades nacionais.

Definido o standard nacional, com a uniformização dos conceitos e requisitos, poder-se-á defender a implementação de políticas de avaliação de qualidade, com auditoria baseada num referencial para o acompanhamento da implementação das Recomendações Técnicas pelas Unidades de Saúde.

O presente documento é complementar às Recomendações Técnicas para Serviços de Urgências, da ACSS.

4. CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO

A Sala de Emergência é fisicamente individualizada relativamente ao restante Serviço de Urgência.

A Sala de Emergência deve localizar-se próximo da entrada de emergência do Serviço de Urgência, em área de tratamento clínico e próximo do posto de triagem de prioridades, com acesso fácil a partir do cais de ambulâncias de emergência.

Deverá existir acesso direto à Sala de Emergência a partir da entrada do Serviço de Urgência, sem passagem por outros espaços funcionais. O acesso deverá ser facilitado seja a partir da entrada da urgência ou da emergência, caso sejam distintas (ver Recomendações Técnicas para Serviços de Urgência)

Existirão dois acessos separados à Sala de Emergência, para entrada e saída de macas, sendo recomendado um circuito unidirecional no fluxo de entrada e saída de doentes.

A Sala de Emergência dispõe de portas de correr nos acessos, com espaço amplo para a passagem de macas com doente e equipamentos, desejavelmente com sistema de abertura controlada de acesso específico (que impede acesso não autorizado, mas possibilita abertura imediata com acionamento de alarme).

A ativação da equipa de apoio à Sala de Emergência é efetuada através de campainha/ sirene de aviso a partir da entrada da Sala.

A saída da Sala de Emergência deverá ser realizada pelas circulações de serviço sem contacto com outros doentes, nem salas de espera ou locais públicos.

A Sala de Emergência será configurada em espaço aberto, com capacidade de unidades individuais de reanimação para um mínimo de 2 doentes em Serviços de Urgência Médico-Cirúrgica e de 3 doentes nos Serviços de Urgência Polivalentes. Um posto de reanimação deve ser entendido como uma unidade com os meios adequados para a abordagem, reanimação e estabilização de um doente crítico, seja do foro médico ou cirúrgico, incluindo trauma.

Consoante a organização interna do hospital, nomeadamente se existe inclusão da gestão de doentes muitos urgentes (além dos emergentes) e a casuística verificada localmente, poderá ser aconselhado dispor de mais postos adicionais de reanimação na Sala de Emergência.

Deverá prever-se, no mínimo, a duplicação de capacidade de lotação da Sala de Emergência (no interior desta Sala ou em espaços próximos com logísticas adequadas para o efeito) em caso de situação de múltiplas vítimas, com o acionamento do plano de catástrofe. O espaço de cada doente na Sala de Emergência deverá ter possibilidade de isolamento com cortinas ou biombos, resguardando a necessária privacidade (segundo recomendações técnicas ACSS).

Em circunstâncias muito específicas, necessariamente limitadas às unidades de saúde dotadas da maior diferenciação e capacidade logística para rentabilizar o investimento, onde se exige casuística importante e disponibilidade de recursos na equipa multidisciplinar e multiprofissional, poderá ser equacionada a hipótese de uma Sala Híbrida, em articulação com a Sala de Emergência, com capacidade angiográfica e até cirúrgica para procedimentos mais complexos. Necessariamente, para a capacidade de imagem e operatória em causa, especialmente em intervenções vasculares, as dimensões dos espaços e a complexidade das logísticas a prever serão outras, além do presentemente descrito para a Sala de Emergência em geral.

Cada unidade em Sala de Emergência deverá ter uma área de 20 a 25m² (em espaço aberto ou delimitado em box, respetivamente), à semelhança das unidades de cuidados intensivos nível II ou III. A distância entre eixos de macas não deverá ser inferior a 2.40m deixando 1.50m livres de cada lado da maca, permitindo o acesso ao

doente a toda a volta (360°) e a presença em simultâneo de toda a equipa multiprofissional e multidisciplinar requerida para a abordagem do doente crítico.

Todas as macas possibilitarão posicionamentos diversos, capacidade de chassis para realização de Raio X, para dispositivos para colocação de perfusões endovenosas (incluindo em seringa ou bomba elétrica) para a colocação e fixação de monitor e ventilador portátil.

Deverão existir condições físicas e materiais para a realização de técnicas como a intubação endotraqueal, acessos vasculares arteriais e venosos (periféricos e centrais), desfibrilhação elétrica, colocação de marca-passo externo, dreno torácico e/ou cateter urinário, entre outros procedimentos.

Devem existir espaços e meios adequados para guardar e condicionar todos os equipamentos abaixo listados.

Tendo em conta a utilização de pendentes e equipamento de radiologia suspensos, deverá acautelar-se a resistência dos tetos e garantir um pé-direito livre mínimo de 3.00,

A atividade desenvolvida na Sala de Emergência é geradora de intenso ruído pelo que este espaço carece de um cuidado tratamento acústico.

A constituição das paredes deverá incluir as necessárias proteções contra radiações tendo em conta a utilização, na sala de emergência, de aparelhos de radiologia.

O revestimento das paredes deverá garantir a possibilidade de limpeza e desinfecção, não ser porosa e não ter juntas. Será durável e de cor clara.

As paredes deverão ser protegidas contra embates, conforme recomendações técnicas ACSS.

O revestimento do pavimento deverá ser antiderrapante, anti estático, condutivo, resistente a fluidos e de fácil limpeza, durável e com absorção de choque, com classificação U3P3E3C2 ou G4ws.

- Com segurança contra incêndio;

Na Sala de Emergência o doente não tem acompanhante permanente, exceto na situação da visita de curta duração, justificada caso a caso.

Eventualmente integrado no serviço de urgência embora sempre próximo e da responsabilidade exclusiva da sala de emergência, haverá uma arrecadação para materiais e equipamentos, com tomadas para recarga dos mesmos.

• Relações funcionais:

Em continuidade: entrada do Serviço de Urgência; circulações; armazém específico da Sala de Emergência.

Em proximidade: Triagem; informação a familiares; sala de espera; banho assistido (ou área de descontaminação).

Acesso fácil (preferencialmente em proximidade horizontal): Radiologia; angiografia; hemodinâmica da cardiologia; bloco operatório; cuidados intensivos; IS pessoal; laboratório de patologia clínica (através de tubos pneumáticos); casa mortuária (através de circuito protegido)

• Equipamentos médicos

-Material de intubação endotraqueal, acesso vascular (venoso e arterial), intraósseo, drenagem torácica, cateterização urinária, equipamento de reanimação pediátrica (mesmo na situação da Sala de Emergência geral), entre outros que sejam necessários.

-Carro de Emergência (com respetivo equipamento), especificamente em apoio à Sala de Emergência (1).

-Carro de Emergência Pediátrico (com respetivo equipamento), independentemente de se tratar de Sala de Emergência geral/ adultos, quando os equipamentos não estiverem incluídos no Carro de Emergência genérico (1).

-Kit de Partos, independentemente de se tratar de Sala de Emergência geral (1)

-Carro de Via Aérea Difícil (com respetivo equipamento) especificamente em apoio à Sala de Emergência (1).

-Cofre para fármacos controlados, com listagem de fármacos e afixação de algoritmos SAV e SAV P (1).

- A Sala de Reanimação deve estar dotada de máquinas para se efetuar TSR.
- Proteção de chumbo em biombo amovíveis disponíveis na Sala de Emergência, para a proteção de outros doentes e dos profissionais. Coletes de chumbo para proteção individual.
- Equipamentos de proteção individual (EPI) disponíveis na Sala de Emergência para a proteção dos profissionais.
- Dispensadores de desinfecção/higienização das mãos

Em cada posto de reanimação/ maca existe capacidade de monitorização dos sinais vitais de cada doente, em simultâneo, por meio de monitores adequados, no mínimo com traçado ECG, Frequência Cardíaca, Pressão Arterial (invasiva e não invasiva), Saturação O2 e Capnografia/ Capnometria (com capacidade de monitorização hemodinâmica invasiva nos Serviços de Urgência Polivalentes e Serviços de Urgência Médico-Cirúrgicos).

No caso de equipamentos de monitorização fixos, estes deverão ser colocados em pendentes seguros no tecto, mas móveis de forma que permitam o seu posicionamento em relação à maca.

Desejavelmente, o material de monitorização de sinais vitais e de ventilação mecânica de base já deve ser portátil, acoplado à maca da Sala de Emergência por meio de dispositivo seguro que permita o transporte subsequente no interior do Hospital, sem necessidade desmonitorização e monitorização sucessiva.

Desfibrilhador Elétrico manual, com Marca-passo Externo, especificamente em apoio à Sala de Emergência (mínimo de 2). No Serviço de Urgência Polivalente e no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico deve haver outro Desfibrilhador elétrico, com pás multifunções), disponível no Serviço de Urgência.

Compressor Mecânico Externo, para a manutenção da compressão cardíaca externa (1).

Eletrocardiógrafo, preferencialmente com capacidade de exportação de dados para o processo clínico eletrónico (1).

Capacidade de ventilar mecanicamente (Com vários modos ventilatórios) todos os doentes, em simultâneo, de forma não invasiva ou invasiva.

Material portátil de monitorização de sinais vitais e de ventilação mecânica, especificamente alocado à Sala de Emergência (2 conjuntos de equipamentos no caso do Serviço de Urgência Polivalente ou Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico).

Seringa de Perfusão Elétrica (6 por cada maca).

Bomba de Perfusão Elétrica (3 por cada maca).

Máquina de infusão EV rápida, com aquecimento de fluidos para administração EV (mínimo de 1 por cada 3 macas).

Aquecedor de Fluidos para administração EV (mínimo de 1 por cada 3 macas).

Aquecedor de doentes por meio de ar quente (mínimo de 1 por cada 3 macas).

Estufa para aquecimento de fluidos (1).

Frigorífico para fármacos (1).

Raio X portátil (1) quando necessário para realização de exames na Sala de Emergência.

É recomendada a disponibilidade de aparelhos de montagem no teto (se existirem condições técnicas para o efeito), instalados em calha que sirva mais do que um espaço de reanimação.

Ecógrafo, com sondas abdominais (na Sala de Emergência).

Ecógrafo, com sondas cardíacas e doppler (rentabilizando o Ecógrafo da Sala de Emergência ou disponível em apoio imediato à Sala de Emergência).

Oftalmoscópio (1).

Otoscópio (1).

Termómetro Digital Timpânico (1)

Máquina medidora de Glicemia e cetonemia (1).

Área de armazenamento de equipamentos com possibilidade de recarga elétrica contínua dos mesmos.

Material para a realização de técnicas como a intubação endotraqueal, acessos vasculares arteriais e venosos (periféricos e centrais, incluindo material para a eventualidade de transfusão maciça), drenagem torácica, toracotomia de emergência, pericardiocentese, colocação de sonda tipo Blackmore, paracentese, punção lombar, cateterismo urinário, entre outros procedimentos consoante o aplicável.

Material para ECMO – Oxigenação por Membrana Extracorporal, em circunstâncias específicas nas unidades hospitalares autorizadas e previstas para o efeito.

Material de imobilização: Plano Duro e Estabilizador Lateral da Cabeça (1 conjunto por posto de reanimação); Colares Cervicais (conjuntos com diversos tamanhos, em quantidade suficiente para a imobilização de cada doente na Sala de Emergência); Cinta de Contenção Pélvica (mínimo de 2 tamanho standard); Maca Scoop (1 por Sala de Emergência), kit de cricotirotomia e traqueostomia, transfer de doentes

Maca de vácuo

Referenciar os circuitos de limpos e sujos

Sinalética no chão do espaço que cada profissional deverá ocupar de acordo com a função a exercer

Torniquetes de Membros (em quantidade suficiente para a eventualidade de utilização em cada doente na Sala de Emergência).

Torniquete juncional (um no mínimo).

Acesso imediato e permanente na Sala de Emergência, ou em espaço imediatamente contíguo à mesma, a Máquina de Gasimetria Arterial.

Acesso a equipamento de hipotermia (em articulação com a Unidade de Cuidados Intensivos).

Opcionalmente, consoante a organização interna do Hospital, uma máquina de Anestesia (neste caso, é requerido sistema de exaustão de gases e acesso a Protóxido de Azoto canalizado, além do requisito base em Ar comprimido e Oxigénio).

No caso de Serviço de Urgência Básico em Unidade de Saúde sem Laboratório, existe acesso a testes analíticos rápidos, tipo Point of Care.

• Instalações e equipamentos elétricos

Considerando a possibilidade de se praticarem técnicas invasivas neste espaço, a distribuição de energia elétrica recorrerá ao regime de neutro isolado (Sistema IT), complementado com medidas suplementares contra contactos indiretos: equipotencialização de todas as partes metálicas normalmente sem tensão elétrica (“massas”) com a terra de proteção.

Os transformadores isoladores de uso médico devem ter duas alimentações, uma a partir da rede UPS e outra a partir da rede socorrida. Estando normalmente limitados a 5 kVA, caso a potência dos recetores elétricos supere esse valor, os mesmos devem ser ligados a tomadas especialmente sinalizadas e ligadas ao Sistema normal utilizado (TT, TN-C ou TN-S).

No interior deste espaço devem ser disponibilizadas informações respeitantes a defeitos de isolamento, estado de carga e temperatura interior dos transformadores de isolamento, devendo ser emitido um sinal visual e sonoro sempre que se verificar um dos seguintes acontecimentos anómalos:

- Defeito de isolamento;
- Carga superior a 90% da capacidade do transformador;
- Temperatura interior do transformador superior a 90% do limite máximo recomendável.

Ao primeiro defeito, apenas será emitida sinalização de aviso no respetivo controlador de isolamento (CPI), sendo o corte apenas efetuado com o aparecimento de um segundo defeito.

O pavimento deve ser anti-estático condutivo e respeitar as RTIEBT - Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro).

Todas as partes metálicas não elétricas (vulgo “massas”), os bornes de terra das tomadas de corrente e os pavimentos anti-estáticos condutivos devem ser ligados a um barramento de equipotencialidade, próprio do compartimento, conforme expresso no primeiro parágrafo deste ponto.

Devem ser previstos ligadores de equipotencialidade junto a cada cama.

Rede UPS:

- A UPS deve ser alimentada a partir da rede socorrida e a sua autonomia não deverá ser inferior a 30 minutos;
- No interior deste espaço devem ser disponibilizadas informações respeitantes ao estado de carga da UPS, devendo ser emitido um sinal visual e sonoro sempre que se verificar um dos seguintes acontecimentos anómalos:
- Avaria da UPS;
- Carga inferior a 50% da capacidade da mesma.

ILUMINAÇÃO:

- Nível médio de iluminação recomendado, ao nível do posto de reanimação é de 300 lux, quando em simples observação, e de 1000 lux, quando em exames ou tratamentos. É garantido um índice de restituição cromático mínimo de 90, com boa uniformidade ao nível do plano de observação;
- Existe regulação do fluxo luminoso;
- Existe sistema de luz sem sombra (pantof), disponível em focos móveis fixos no teto ou em pendentes, com um mínimo de 80.000 lux de iluminação (equivalente a Sala de Operações no Bloco Operatório);
- Existem focos direccionáveis e reguláveis em apoio à realização de técnicas.

TOMADAS DE ENERGIA:

- 20 por posto de reanimação / maca, situadas em sistema pendente no tecto e alimentadas por UPS (conforme norma a atender para Unidade de Cuidados Intensivos).
- 1 tomada com terra para equipamento de Radiologia por cada 3 macas.
- Haverá ainda tomadas para recarga dos equipamentos técnicos junto aos locais de estacionamento dos mesmos.

COMUNICAÇÕES:

- 2 tomadas duplas RJ 45, por posto de reanimação;
- 1 sistema de chamada e intercomunicação de porteiro ou videoporteiro, com a portaria do Serviço de Urgência;
- 1 campainha/ sirene de aviso a partir da entrada da Sala de Emergência para a activação da equipa de emergência;
- 1 campainha/ sirene de aviso para equipa chamar segurança quando necessário (este aviso apenas toca junto do posto de Segurança, não toca na Sala de Emergência);
- Pré instalação compatível com Rádio INEM;
- Sistema sonoro em alta voz (public address system).

Relógio de parede analógico com indicação de segundos.

Relógio com cronometro, incorporado no Monitor de Sinais Vitais.

Relógio com cronometro, integrado no sistema informático de registo clínico de forma a indexar a hora do início da observação médica.

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO:

- Em braço articulado, junto a cada maca, haverá um computador, teclado e monitor Norma Médica
- No mínimo haverá dois computadores em mesa de trabalho, com teclado e monitor Norma Médica;
- No mínimo, haverá dois ecrã/ monitores de alta resolução para a visualização de resultados da imagiologia (podem ser os mesmos dos computadores de base);
- Impressora.
- Junto de cada maca haverá acesso informático ao registo clínico electrónico, a resultados analíticos, visualização de imagiologia e consulta de registos externos (Telemedicina, Registo de Certificação de Óbitos e acesso a PDS, entre outros), preferencialmente sem fios.
- Sistema Gricode para segurança em transfusão de hemoderivados

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

Sistema que garante as adequadas condições de temperatura, humidade e qualidade do ar interior.

Não se justifica, na Sala de Emergência a existência de diferencial de pressão relativamente ao exterior.

GASES MEDICINAIS:

Cada posto reanimação / maca dispõe de:

- 3 saídas de O₂ canalizado em pendente, mais 3 saídas com medidor de fluxo;
- Ar comprimido 2 saídas em pendente, mais 2 com medidor de fluxo;
- Vácuo de parede, 3 saídas montadas em pendente.

Caso exista Máquina de Anestesia é requerido sistema de exaustão de gases e acesso a Protóxido de Azoto canalizado, além do requisito base em Ar comprimido e Oxigénio.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos:**

Lavatório, conforme o disposto nas Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010.

Tina de desinfecção, cumprindo requisitos aplicáveis a Sala de Operações no Bloco Operatório.

Área de lavagem de sujos e armazenamento até transporte a depósito de sacos.

Acesso a duche em proximidade para banho dos profissionais.

Desejavelmente, acesso à possibilidade de descontaminação com chuveiro, com privacidade e controlo de águas residuais, com proteção individual dos profissionais.

5. **BIBLIOGRAFIA:**

Australasian Health Facility Guidelines 2017

International Health Facility Guidelines 2017

Manual de Standards – Unidades de Urgência e Emergência. Direção Geral da Saúde 2016

International Health Facility Guidelines 2015

Recomendações Técnicas para Serviços de Urgências. Administração Central do Sistema de Saúde RT 11/2015

Guidelines for a Structured Approach to the Provision of Optimal Trauma Care. Royal Australasian College of Surgeons – New Zealand Trauma Committee 2012

Recommendations on Basic Requirements for Intensive Care Units. European Society of Intensive Care Medicine 2011

Standards for Emergency Department Design and Specification. Irish Association of Emergency Medicine 2007

Recomendações sobre a Organização dos Espaços do Serviço de Urgência. Direção Geral das Instalações e Equipamentos da Saúde 2007

Emergency Department Design – A Practical Guide to Planning for the Future. American College of Emergency Physicians 2002

A Organização da Sala de Emergência. Instituto Nacional de Emergência Médica 1999

Recommendations on Minimal Requirements for Intensive Care Departments. European Society of Intensive Care Medicine 1997

6. GRUPO DE TRABALHO

Na elaboração deste documento colaboraram os seguintes elementos:

- António Marques – Presidente da Comissão Nacional de Trauma
- Dra Margarida Rios – Comissão Nacional de Trauma
- Doutor José Amarante – Perito da Comissão Nacional de Trauma
- Dr Carlos Vaz – Direção Geral da Saúde
- Dra Raquel Ramos – Instituto Nacional de Emergência Médica
- Enf Luís Ladeira – Instituto Nacional de Emergência Médica
- Dra Sofia Silva – Competência em Emergência Médica, Ordem dos Médicos
- Enf José Abrantes – Ordem dos Enfermeiros
- Enf Sérgio Branco – Ordem dos Enfermeiros
- Arq António Campelo – Unidade de Instalações e Equipamentos da ACSS
- Eng João Lima Costa – Unidade de Instalações e Equipamentos da ACSS
- Eng^a Lúcia Dantas – Unidade de Instalações e Equipamentos da ACSS
- Eng Gleber Oliveira – Unidade de Instalações e Equipamentos da ACSS
- Eng Nuno Caldeira – Unidade de Instalações e Equipamentos da ACSS
- Arq Pedro Cabral – Unidade de Instalações e Equipamentos da ACSS

GRUPO DE TRABALHO ALARGADO

- Membros da Comissão Nacional de Trauma
- Dr Júlio Nobrega – Representante do Colégio de Medicina Intensiva, Ordem dos Médicos
- Dr Vitor Almeida – Representante da Competência Emergência Médica, Ordem dos Médicos
- Dra Alexandra Guedes – Representante do Colégio de Anestesiologia, Ordem dos Médicos
- Dr Jorge Pereira – Representante do Colégio de Cirurgia Geral, Ordem dos Médicos
- Dr Vitor Fernandes – Representante do Colégio de Cirurgia Plástica, Ordem dos Médicos
- Dr Mesquita Montes – Representante do Colégio de Ortopedia, Ordem dos Médicos
- Dr Marcos Barbosa – Representante do Colégio de Neurocirurgia, Ordem dos Médicos
- Dr Hugo Marques – Representante do Colégio de Radiologia, Ordem dos Médicos
- Dr José Manuel Oliveira – Representante da Sociedade Portuguesa de Cirurgia
- Dr Sérgio Faria Baptista – Representante da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
- Dr António Pais Martins – Representante da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos
- Dr Domingos Coiteiro – Representante da Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia
- Doutor Fernando Fonseca – Representante da Sociedade Port. de Ortopedia e Traumatologia
- Dra Miroslava Gonçalves – Representante da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Pediátrica

- Dra Marisa Vieira – Representante da Sociedade Portuguesa de Pediatria
- Dra Patrícia Mação – Representante da Sociedade de Urgência e Emergência Pediátrica
- Dra Marisa Vieira – Representante da Sociedade de Cuidados Intensivos Pediátricos

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16, Avenida do Brasil, 53

1700-063 LISBOA | Portugal

Tel Geral (+) 351 21 792 58 00 Fax (+) 351 21 792 58 48



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

SAÚDE

WWW.ACSS.MIN-SAÚDE.PT